

☒ ACOMPANHAMENTO ( ) CONSULTA  
NS 22231696605 362

MARCO ANTONIO BARROS DOS SANTOS

IDADE: 60 anos PESO: 86 ALTURA: 1,74 PROFISSÃO: Engenheiro / Empresário  
SINTOMAS: Ainda cansado; sono leve  
QUEIXAS: Dorco  
MEDICAMENTOS: Citalopram, Concordio - HAS

MÉDICO: Dr Carlos Leite - Cardio  
EXERCÍCIO FÍSICO: 0

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:  
HORA QUE DORME: 23h 00h HORA QUE ACORDA: 7h  
COCHILO ( ) SIM ( ) NÃO DORME ACOMPANHADO ☒ SIM ( ) NÃO ( ) EVENTUAL  
BEBIDA ALCOÓLICA ☒ SIM ( ) X NA SEMANA ( ) NÃO FDS social  
FUMO ( ) SIM ( ) MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:  
TIPO DE RESPIRAÇÃO: BANHEIRO: 1x  
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:  
OVERLAP: MALLAMPATI: III IAH: 84,4 e/h SPO2: 71%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:  
CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA  
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:  
COMORBIDADE: ( ) RESPIRATÓRIA ( ) ENDÓCRINA (S) CARDÍACA  
( ) ORTOPÉDICA ( ) NEUROLÓGICA ( ) OUTROS

02/02 - Avaliação - Locapex, Yuwell

09/02/24 P= 9cmH<sub>2</sub>O Pao: 12cmH<sub>2</sub>O  
IAH= 6,3 e/h  
m. uso: 7h30'  
fuga: 6l/min

23/02/24 P= 8,9 cmH<sub>2</sub>O Pao: 12cmH<sub>2</sub>O  
IAH= 3,4  
m. uso: 7h19' fixamos em P= 10cmH<sub>2</sub>O  
fuga: 8l/min Natália

05/03/24 P= 9,8 cmH<sub>2</sub>O (95% 10,2cmH<sub>2</sub>O)  
IAH= 4,9  
m. de uso: 7h56' flia.

27/03 P= 9,8cmH<sub>2</sub>O  
IAH= 1,7 e/h  
fuga: 42,8 flia

26/04/24 P= 9,8 cmH<sub>2</sub>O Bem adaptado  
IAH= 1,6 e/h Fazendo atividade física  
fuga: 48,5 l/min 3x semana  
Natália



Nome: MARCO ANTONIO BARROS DOS SANTOS

Data de Nascimento: 11-7-1963

IMC: 29,75

Sexo: Masculino

Data do exame: 11-01-2024

Peso: 87 kg

Altura: 1,71 m

Médico: DR. CARLOS EXPEDITO BENTO

LEITÃO

Medicamentos:

Histórico:

### Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 11-01-2024, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 505,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 104,0 e 135,5 minutos. O tempo total de sono foi de 284,5 min, eficiência de 56,3% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,6%; estágio N2: 65,7%; estágio N3: 8,1%; sono REM: 24,6%. O índice de despertares foi de 36,5/hora (normal < 10/h).

O índice de apnéia/hipopnéia total foi de 84,4/hora, sendo 80 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 138 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 71%, permanecendo 24,6% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 45 - 79 bpm e NREM de 43 - 71 bpm.

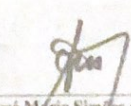
**CONCLUSÃO:** Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (15), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 84,4/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=71%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

**Exame evidenciando apnéia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.**

IAH: 05-15 /hora leve.  
IAH: 15-30 /hora moderada.  
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.

  
Dr. José Mario Simões da Costa  
Medicina do Sono  
CRM 57157